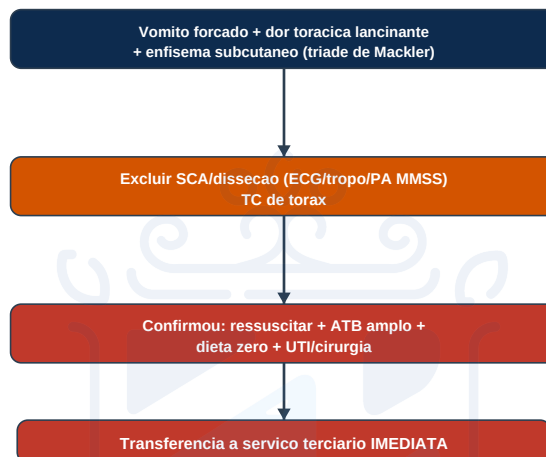


SÍNDROME DE BOERHAAVE — RUPTURA ESOFÁGICA

FLUXOGRAMA — DOR TORÁCICA APÓS VÔMITO

BOERHAAVE — PENSAR PARA DIAGNOSTICAR



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Perfuração TRANSMURAL ESPONTÂNEA do esôfago
- Mecanismo: aumento súbito da pressão intraesofágica + pressão intratorácica negativa
- Causas: VÔMITOS FORÇADOS (mais comum), tosse vigorosa, levantamento de peso, convulsão, parto, Valsalva intensa
- Fatores de risco: abuso de álcool, patologia esofágica prévia (estenose, acalasia), hérnia hiatal, DRGE mal tratada
- Alta morbimortalidade — diagnóstico precoce é crítico

QUANDO SUSPEITAR

QUADRO CLÍNICO

- TRIÁDE DE MACKLER (clássica, mas rara): vômitos + dor torácica + enfisema subcutâneo
- Dor torácica súbita e intensa/lancinante (pode irradiar para dorso/ombros, ± dor epigástrica)
- História de vômitos/êmese precedendo a dor
- Enfisema subcutâneo (crepitação à palpação cervical/torácica)
- Estertores, diminuição do murmúrio (derrame pleural); sinais de peritonite se perfuração intra-abdominal

AValiação e Diferencial

EXAMES

- Em esforço agudo + fatores de risco + dor torácica atípica para SCA, lancinante: pesquisar ativamente
- ECG + troponina para excluir IAM; avaliar simetria de PA em MMSS (excluir dissecação de aorta)
- RX de tórax (pneumomediastino, derrame, hidropneumotórax) ou TC de tórax (melhor)
- EDA se TC com achados duvidosos (cautela)
- Rastreio infeccioso e culturas

TRATAMENTO NO PS — PRIMEIRA HORA

Rx RESSUSCITAÇÃO + ATB + JEJUM

Ressuscitação volêmica agressiva: 2 acessos calibrosos, Ringer/SF, bolus 20-30 mL/kg
Noradrenalina em BIC se PAM < 65 após volume; monitorização hemodinâmica
DIETA ZERO absoluta (nutrição por jejunostomia/NPT só após 24-48h, estável)
ATB amplo espectro IMEDIATO: Piperacilina-tazobactam 4,5g IV 6/6h OU Meropenem 1g IV 8/8h (ou Ampi-sulbactam 3g 6/6h); alergia a betalactâmico: Clindamicina + Ciprofloxacino
Considerar antifúngico (Fluconazol) se hospitalização/ATB amplo prévios à perfuração

MEDIDAS DE SUPORTE

Rx PRESCRIÇÃO COMPLEMENTAR

Analgesia: opioide (Morfina 2-10mg IV titulada); EVITAR AINE (risco de sangramento)
Antiemético: Ondansetrona 4-8mg IV 8/8h; EVITAR metoclopramida (aumenta pressão intraesofágica)
IBP: Omeprazol/Pantoprazol 40mg IV 12/12h + ataque 80mg EV
O2 suplementar; IOT se insuficiência respiratória ou dor refratária extrema
SNG: CAUTELA (risco de piorar a laceração) — só guiada por EDA, após discutir com cirurgia/gastro

RED FLAGS — POR QUE É EMERGÊNCIA

INTERNAR TODOS EM UTI

- Mediastinite e sepse evoluem rapidamente -> alta mortalidade
- Internar TODOS os casos confirmados ou de alta suspeita
- Solicitar VAGA DE UTI para todos pela alta morbimortalidade
- Encaminhamento a serviço terciário (cirurgia torácica) IMEDIATO
- O tratamento definitivo (cirúrgico/endoscópico) depende do tempo e da extensão — não atrasar a transferência

CHECKLIST NO PS

NÃO ESQUECER

- ☐ Pensar em Boerhaave em dor torácica lancinante pós-vômito (não rotular como SCA/gastrite)
- ☐ Excluir IAM e dissecação de aorta em paralelo
- ☐ Dieta zero + ATB amplo precoce + ressuscitação volêmica
- ☐ Evitar metoclopramida e SNG às cegas
- ☐ Acionar cirurgia torácica + vaga de UTI + transferência imediata

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Suspeita/confirmação de Síndrome de Boerhaave: dor torácica lancinante pós-vômito + enfisema subcutâneo.
- TC de tórax: pneumomediastino/derrame/perfuração em _____. IAM e dissecação excluídos.
- Condutas: dieta zero, ATB amplo (____) às _____, ressuscitação volêmica, $\pm$ noradrenalina, IBP.
- Solicito VAGA DE UTI e transferência IMEDIATA para serviço com cirurgia torácica.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Homem etilista, após episódio de vômitos forçados, evolui com dor torácica lancinante e crepitação à palpação cervical. Qual a hipótese e a tríade clássica?

- A) Pericardite — atrito pericárdico
- B) Síndrome de Boerhaave — tríade de Mackler (vômitos + dor torácica + enfisema subcutâneo)
- C) Infarto agudo do miocárdio — supra de ST
- D) Pneumonia — febre e tosse
- E) Refluxo simples — pirose

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o exame de imagem de escolha para confirmar a perfuração esofágica na suspeita de Boerhaave?

- A) Radiografia de abdome
- B) Tomografia de tórax
- C) Ultrassonografia
- D) Cintilografia
- E) Ressonância de crânio

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Sobre o tratamento inicial da síndrome de Boerhaave, é correto:

- A) Iniciar dieta oral precoce
- B) Dieta zero, ressuscitação volêmica e antibiótico de amplo espectro imediato, com internação em UTI
- C) Apenas analgesia e alta
- D) Antibiótico oral
- E) Aguardar 24h para iniciar antibiótico

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual antiemético deve ser EVITADO na síndrome de Boerhaave?

- A) Ondansetrona
- B) Metoclopramida (pode aumentar a pressão intraesofágica)
- C) Dimenidrinato
- D) Bromoprida em dose baixa
- E) Nenhum antiemético é contraindicado

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual cuidado deve ser tomado quanto à sonda nasogástrica na Boerhaave?

- A) Passar de rotina às cegas
- B) Cautela: risco de piorar a laceração; se necessária, sob visualização guiada por endoscopia
- C) Está sempre contraindicada em qualquer situação
- D) Passar apenas pela narina esquerda
- E) Usar a maior sonda disponível

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Dor torácica lancinante pós-vômito forçado com enfisema subcutâneo em etilista sugere síndrome de Boerhaave (perfuração esofágica espontânea); a tríade de Mackler (vômitos + dor torácica + enfisema) é clássica, embora rara.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A TC de tórax é o exame de escolha para confirmar a perfuração (pneumomediastino, derrame, extravasamento). A radiografia pode sugerir, mas a TC define; a EDA fica para achados duvidosos, com cautela.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O manejo inicial é dieta zero, ressuscitação volêmica e antibiótico de amplo espectro IMEDIATO, com internação em UTI e transferência a serviço com cirurgia torácica — a mediastinite/sepse evolui rapidamente.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A metoclopramida deve ser evitada por aumentar a pressão intraesofágica (risco de piorar a perfuração). Prefere-se ondansetrona para o controle de náuseas/vômitos.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A SNG deve ser usada com cautela na Boerhaave (risco de agravar a laceração); se indispensável, colocar sob visualização guiada por endoscopia, após discussão com cirurgia/gastroenterologia.

SM24
Suporte ao Plantão Médico